

Gastrointestinal blødning

Line Pejstrup Søndergård, introduktionslæge
Afdeling for Medicinske Mave- og Tarmsygdomme
Aalborg Universitetshospital



Agenda



Definere de vigtigste blødningssymptomer, herunder hæmatokesi, hæmatemese og melæna



Klinisk præsentation af akutte og kroniske blødninger fra mave-tarm-kanalen



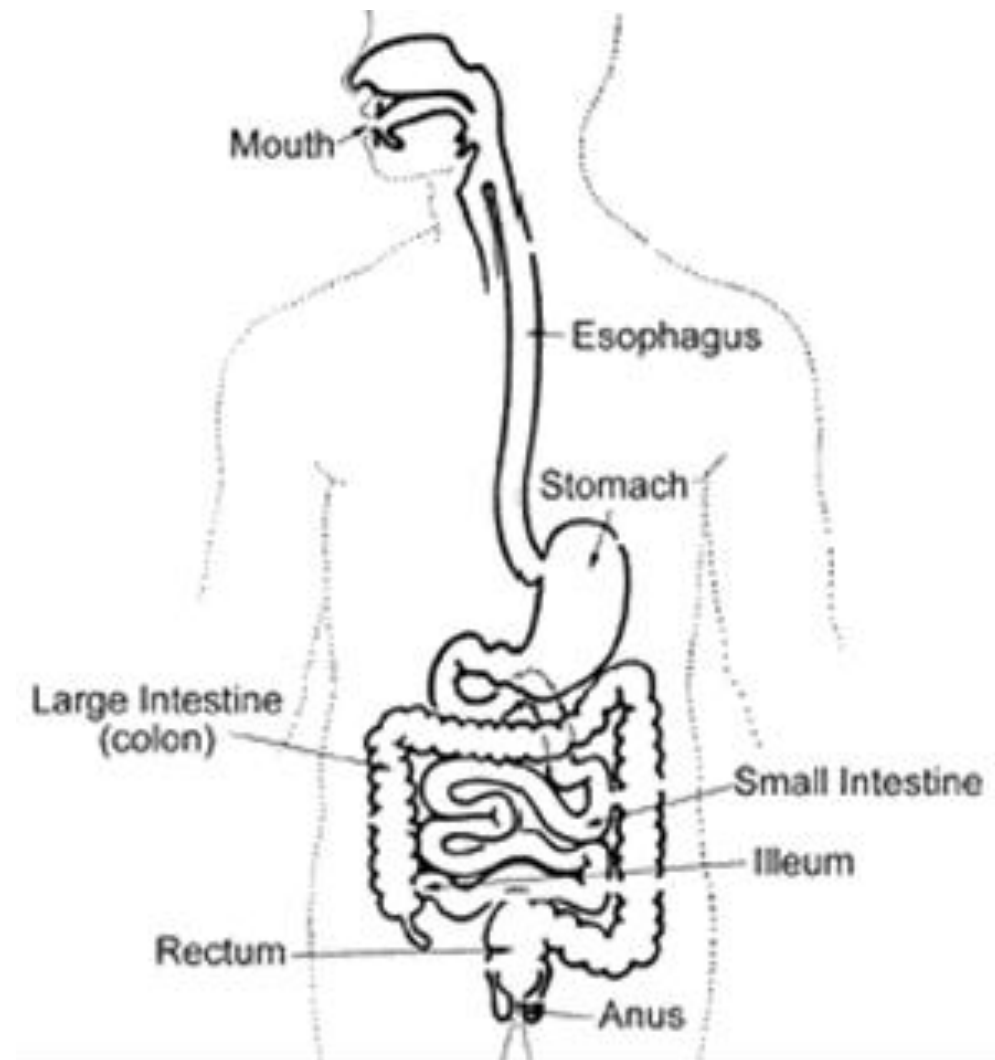
Hovedårsager og risikofaktorer for blødninger fra mave-tarm-kanalen



Beskriv undersøgelser af akut og okkult blødning

Inddeling

- Øvre vs. nedre GI-blødning
- Anatomisk skillelinje: Treitz' ligament
- Øvre GI-blødning, 85-90%
 - Akutte og risiko for udvikling af shock
 - Hyppigst ulcus, dernæst varicer og øsofagit
- Nedre GI-blødning
 - Sjældent akut og oftest selvlimiterende
 - Colon: 70-80%
 - Anorektalt: 5-15%
 - Tyndtarm: <2%



Præsentation af blødning

Hjælper os med at differentiere mellem øvre vs. nedre GI-blødning

Øvre GI-blødning

- Hæmatemese
- Melæna

Nedre GI-blødning

- Hæmatokesi

Øvre GI-blødning

Hæmatemese

- Blodigt opkast
- Rød hæmatemese: Friskt, rødt blod evt. iblandet koagler
- Sort hæmatemese: Kaffegrums-lignende

Melæna

- Sort, tjæreagtig, glinsende og ildelugtende afføring

I kombination eller alene



Nedre GI-blødning

Hæmatokesi

- Rød afføring / rødt blod ved defækation
- Mahognilignende afføring
- Nærmest sort afføring (obs dog ikke melæna)

Mørk farve pga bakteriel og enzymatisk nedbrydning af hæmoglobin

OBS frisk blod pr. rektum kan i enkelte tilfælde repræsentere øvre, alvorlig GI-blødning



Okkult blødning

- Usynligt blod i afføringen
- Langsom blødning - ikke potentiale til akut hæmodynamisk påvirkning
- FOBT: Fecal occult bloodtest
 - Kemisk påvisning af blod i fæces - selv små mængder
 - Indgår i nationalt screeningsprogram for coloncancer, 50-74 årige, hvert 2. år
 - Formål: Opdage tyk- og endetarmskræft samt forstadier (polypper) så tidligt som muligt
- Positiv FOBT --> koloskopi



SUNDHEDSSTYRELSEN

Indgang til Pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm

Til brug i almen praksis

Håndtering af symptomer på kræft i tyk- og endetarm

Et eller flere af nedenstående symptomer eller fund bør, særligt hos personer over 40 år, føre til undersøgelse med palpation af abdomen, rektaleksploration, blodprøver mhp. anæmiudredning samt evt. gynækologisk undersøgelse.

- Blødning fra tarmen uden anden oplagt årsag
- Ændring af et ellers stabilt afføringsmønster i over fire uger
- Nytilkomne mavesmerter, som persisterer over 4 uger
- Uforklaret blødningsanæmi/jernmangelanæmi

Ovenstående liste er vejledende og ikke udtømmende. Nogle patienter med kræft i tarmen vil, i tillæg til ovenstående, have almensymptomer i form af fx vægttab, træthed m.m.

Klinisk præsentation

- Blødningstype
- Akut GI-blødning
 - Påvirkede vitale parametre: Især takykardi og hypotension
 - Kølig, bleg og klam hud perifært
 - Senere takypnø, cerebral påvirkning, oliguri
 - Synkope/nærsynkope
- Kronisk GI-blødning
 - Langvarig, langsom og svag blødning
---> tegn på anæmi

Risikofaktorer for GI-blødning

Fælles	Øvre GI-blødning	Nedre GI-blødning
Høj alder	H. pylori	Obstipation
Rygning	Alkohol	IBD
NSAID		
AK-behandling eller trombocythæmmende midler		
Tidligere blødningsepisoder		

Hovedårsager til GI-blødning

Øvre GI-blødning	Nedre GI-blødning
Peptisk ulcus	Divertikler
Varicer	Hæmorider
Øsofagit/gastrit	IBD
Mallory-Weiss-læsion	Arteriovenøs malformation
Cancer	Cancer

Lad os dykke ned i nogle af dem....

Case



**82-årig kvinde, kendt med
DM2, KOL og hypertension**



Knæoperation 1,5 mdr. siden



Henvender sig til egen læge

Utilpashed

Svimmelhed

Sort afføring i to dage

Ingen mavesmerter



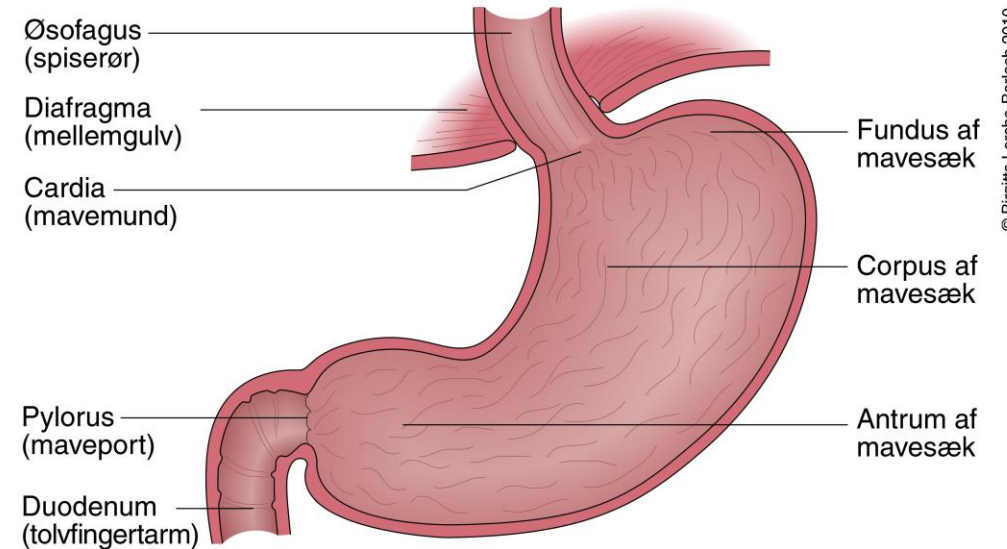
Hvad tænker I om det?

Blødende ulcus

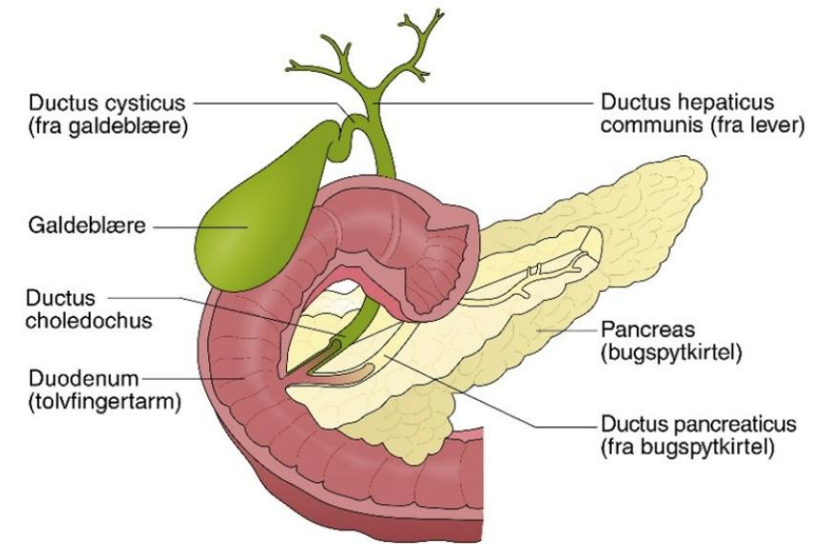
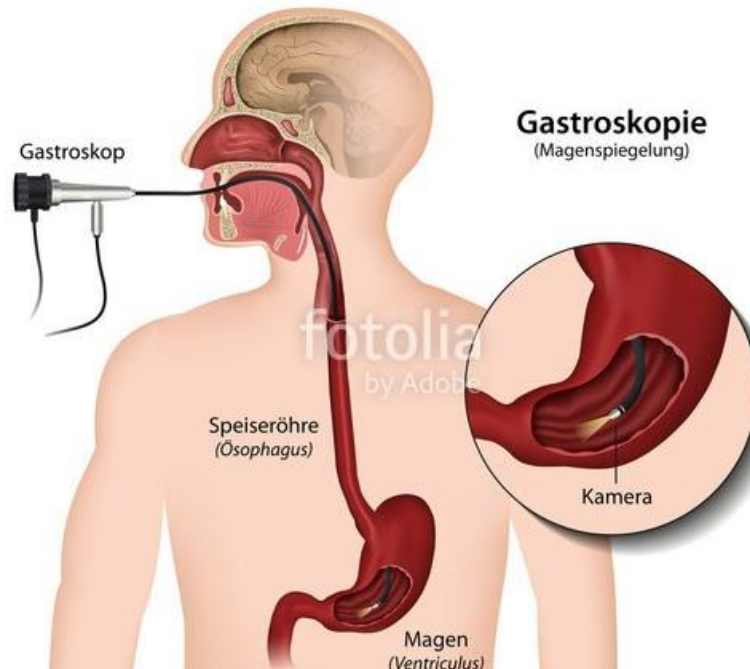
- Hyppigste årsag til øvre GI-blødning
- Høj mortalitet, 10%
- Ubehandlet typisk reblødning indenfor 14 timer
- Substanstab af slimhinde i antrum, præpylorisk, pylorisk eller i bulbus duodenum. Kan involvere alt fra mucosa til serosa
- Blødning skyldes erodering af arterie i ulcusbunden (potentielt livstruende)



Blødende ulcus gør ikke ondt!!! Perforeret ulcus gør...



Endoskopisk behandling af blødende ulcus



Endoskopisk behandling af blødende ulcus

- Vi gennemgår den initiale kredsløbsstabilisering senere
- Endoskopisk behandling er 1. valg
 - Patienter der kan kredsløbsstabiliseres: Gastroskopi indenfor 6-24 timer fra indlæggelsestidspunkt
 - Patienter, der ikke kan kredsløbsstabiliseres indenfor 1 time: Hurtigst muligt
- Endoskopiske metoder
 - Injektion af adrenalin/NaCl – aldrig monoterapi
 - Brænde – aldrig monoterapi
 - Hæmoclips
 - OBS altid biopsi for H. pylori
- Obs risiko for reblødning indenfor 24 timer
 - Gentagelse af endoskopisk behandling
 - Behandlingsrefraktær blødning: Transarteriel embolisering

Medicinsk behandling af blødende ulcus



Syrepumpehæmmere - for bedre heling



Pausering af NSAID, AK-behandling og antihypertensiva under pågående blødning



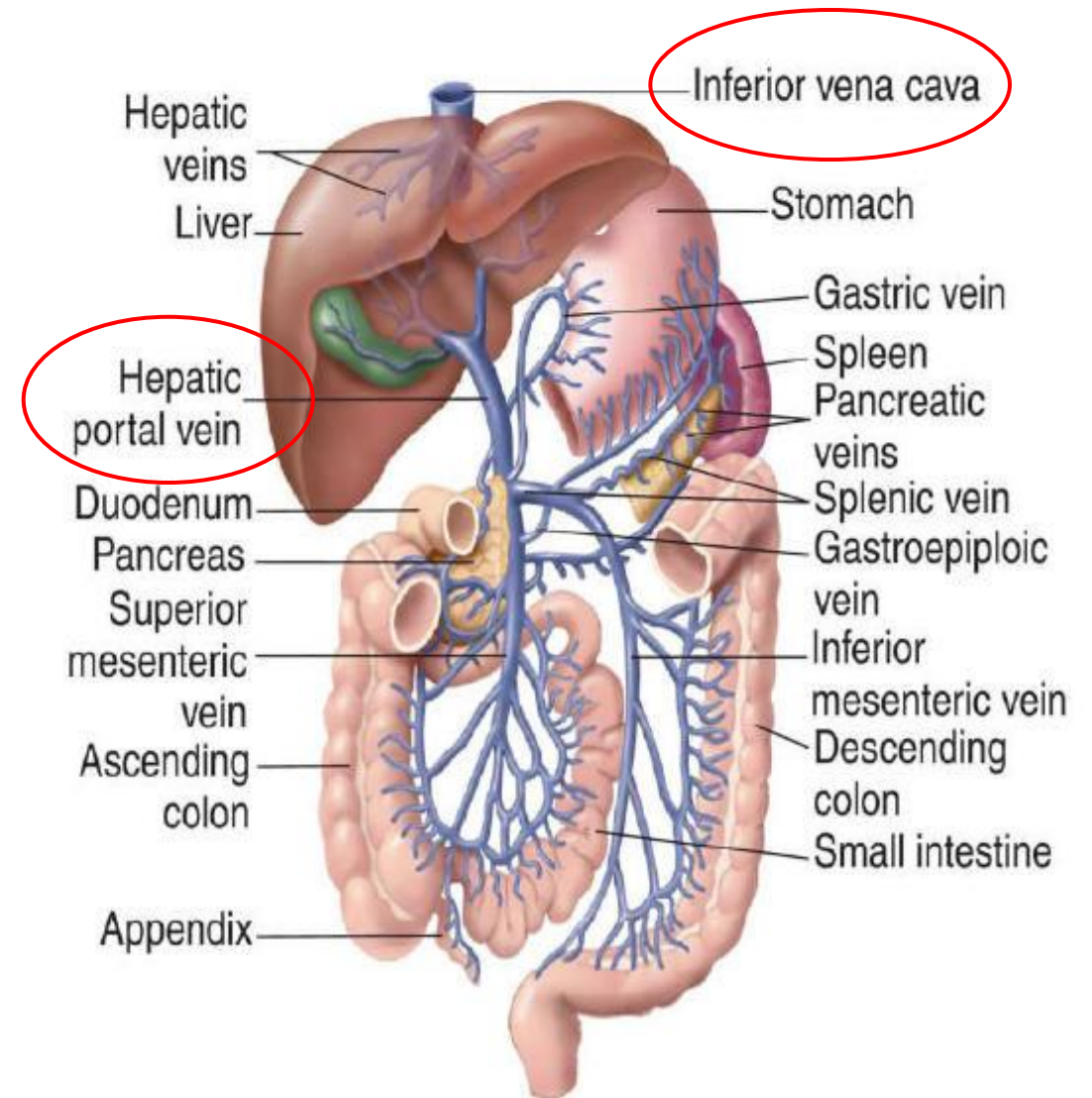
Eradikation af H. pylori

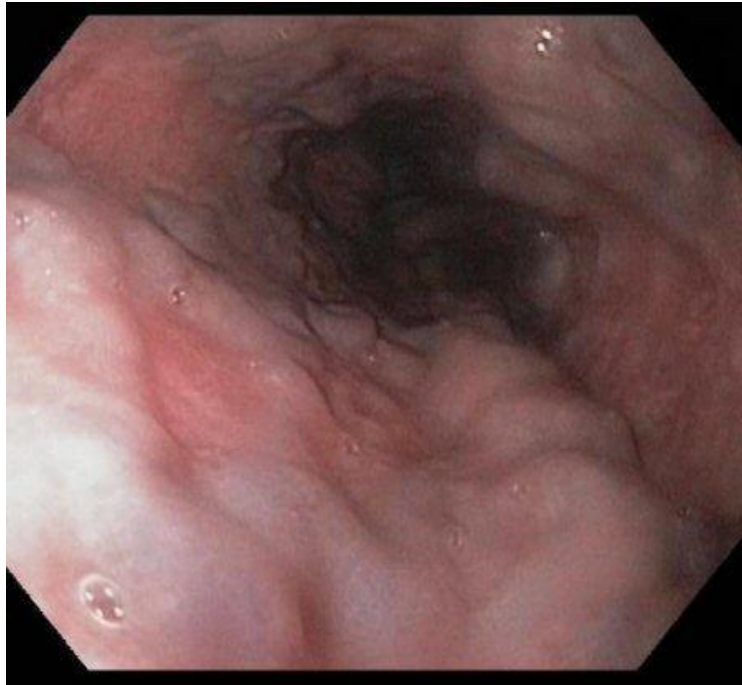
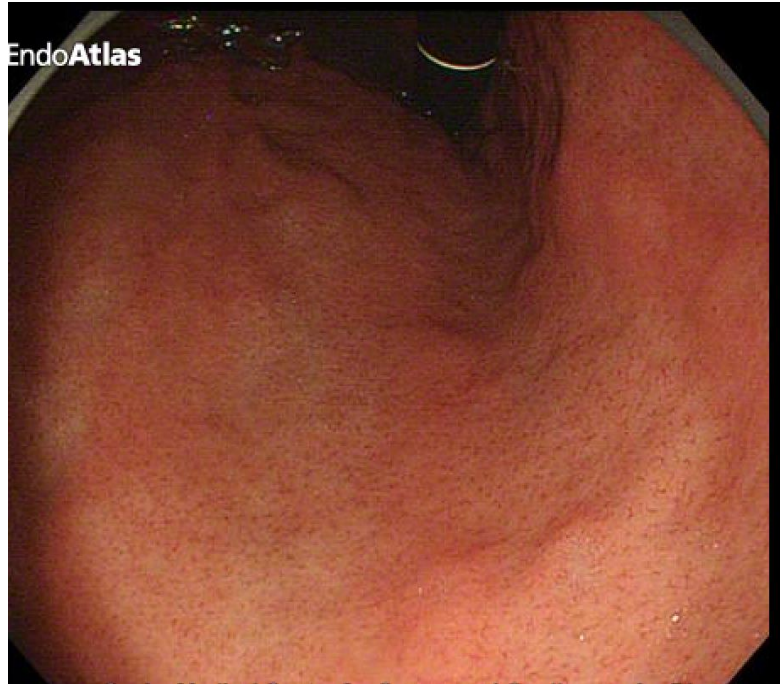


Ophør med NSAID og ASA hvis muligt

Øsofagusvaricer

- Definition: Dilaterede submukøse vener i distale øsofagus
- Ætiologi
 - Levercirrose --> arvæv --> øget tryk i v. porta/portal hypertension
 - Medfører øget backflow af blod til gastriske vener og øsofagale vener --> dilatation af vener
- Risiko for kraftig blødning, hypovolæmi og shock





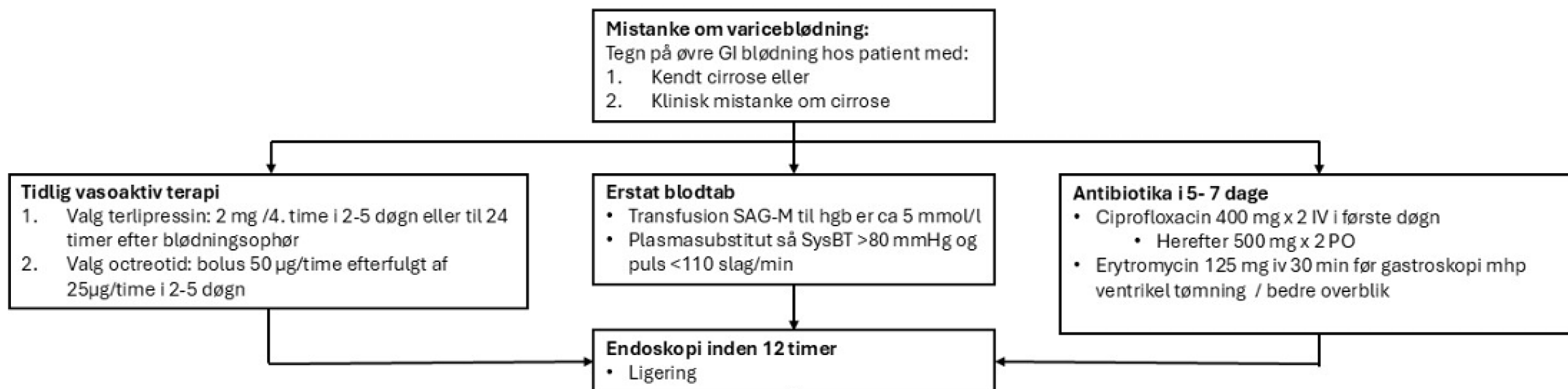
Behandling

20% mortalitet

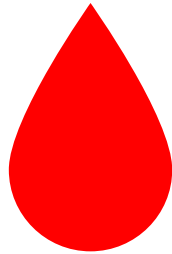
Stabilisering af patienten!

- ABCDE
- Balanceret blodkomponentterapi: 4:4:1 erythrocytter, frisk frosset plasma, trombocytter

Behandling af akut variceblødning



Sekundær forebyggelse af øsofagusvaricer



2/3 oplever reblødning indenfor 1-2 år



Kombineret endoskopisk og farmakologisk behandling

Non-selektiv beta-blokker: Carvedilol

- Alfablokade: Intrahepatisk vasodilation
- Beta-1-blokade: Reduceret cardiac output
- Beta-2-blokade: Vasokonstriktion af splankniske kar

Ligering hver 4. uge til eradikation af varicer
(TIPS)

Divertikulose

- Hyppigste formodede årsag til nedre GI-blødning
- Udposning på colon
 - Består af mucosa, submucosa og serosa
 - Oftest i colon descendens og sigmoideum
- Blødning fra enkeltstående, typisk mindre arterie
- Behandling
 - Oftest selvlimiterende
 - Undgå obstipation

...Kort om kolorektal cancer

- Gennemsnitsalder ved diagnose er 70 år
- Ca. 5000 tilfælde årligt
- Lokalisation
 - 33 %: Rektum
 - 30%: Sigmoidium
 - 25 %: Colon ascendens
- Varierende symptomer
 - Synlig eller okkult blødning. Oftest langsom blødning --> anæmi og træthed
 - Mavesmerter
 - Afføringsændringer
 - Ileus
 - Vægttab

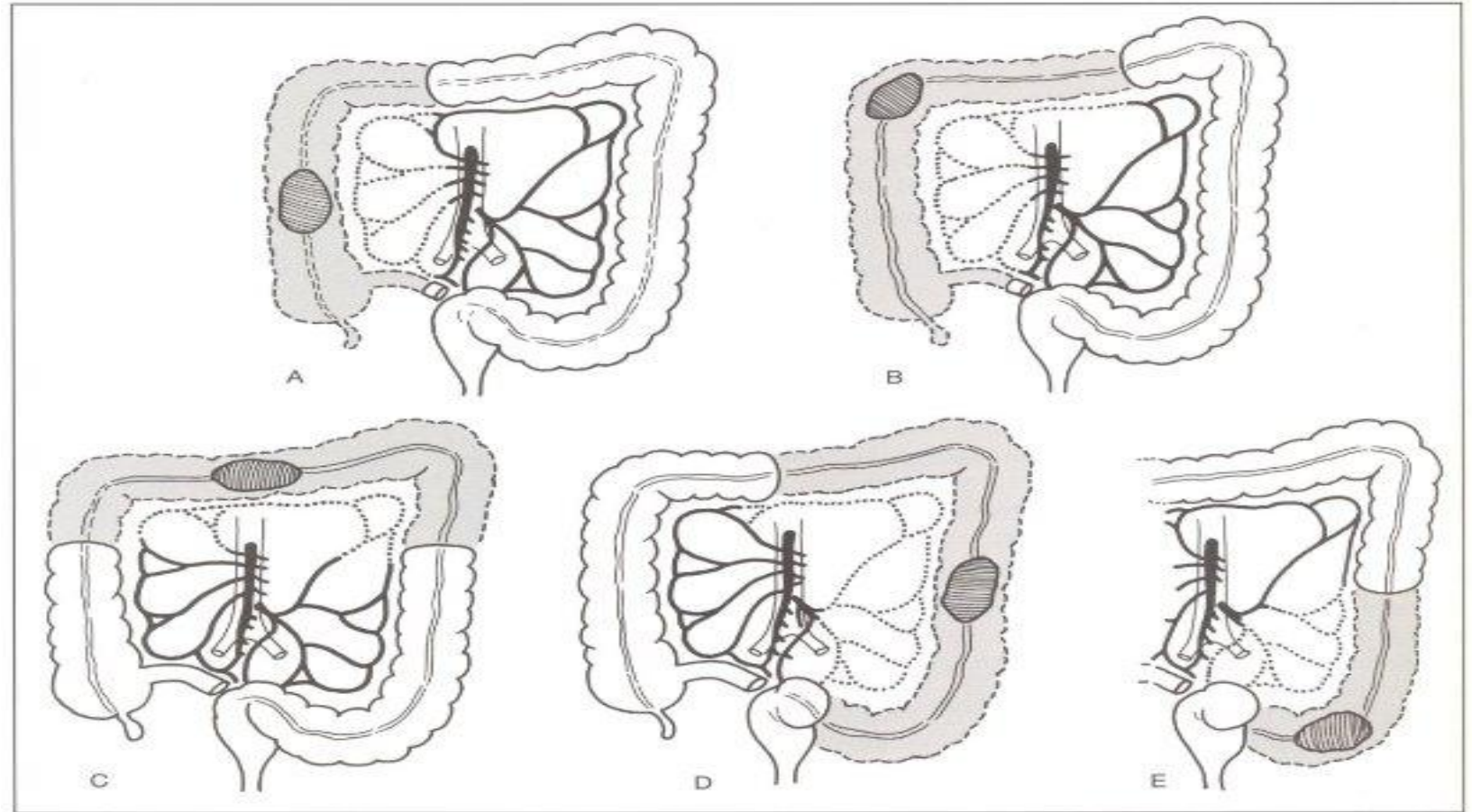
Behandling

Vigtigt med præoperativ vurdering af TNM-stadie, komorbiditeter og AT

Kirurgi

Onkologisk behandling

- Neoadjuverende
- Adjuverende



Figur 47.8. Resektionstyper ved radikal operation for cancer coli. A) højresidig hemikolektomi, B) udvidet højresidig hemikolektomi, C) resektion af colon transversum, D) venstresidig hemikolektomi, E) sigmoideumresektion.

Kan nogen så håndteres ambulant?

- Omkring 40%, der indlægges på mistanke om GI-blødning har ikke behov for transfusion eller endoskopisk behandling
- **Glasgow Blatchford score (GBS)**
 - Risikoscoringssystem til at afgrænse hvilke patienter der kan undersøges subakut ambulant
 - Anbefales udregnet hos alle med mistanke om øvre GI-blødning

Glasgow Blatcford score

Patienter med lav klinisk mistanke om
betydende blødning og GBS ≤ 1



Ambulant gastroskopi indenfor et par dage

Risikofaktorer	Score
<u>P-Carbamid (mmol/L)</u>	
$\geq 6,5 - < 8,0$	2
$\geq 8,0 - < 10,0$	3
$\geq 10,0 - < 25,0$	4
$\geq 25,0$	6
<u>B-hæmoglobin (mmol/L) for mænd</u>	
7,5 – 8,0	1
6,2 – 7,4	3
$< 6,2$	6
<u>B-Hæmoglobin (mmol /L) for kvinder</u>	
6,2 – 7,4	1
$< 6,2$	6
<u>Systolisk blodtryk (mmHg)</u>	
100-109	1
90-99	2
< 90	3
<u>Andre risikofaktorer</u>	
Takykardi ≥ 100 slag/min	1
Forekomst af melæna	1
Forekomst af synkope	2
Leversygdom	2
Hjertesvigt	2

Ref: Stanley AJ, et al. Lancet 2009;373:42-47.



Undersøgelser af akut og okkult blodtab

- Kig på patienten – hvad er mest sandsynligt???
- ABCDE
- Anamnese
 - Blødningsbeskrivelse
 - Risikofaktorer
- Objektiv undersøgelse
 - AT
 - Vitale parametre
 - Rektaleksploration
 - Cirrosetigmata
- Biokemi
 - Hgb, INR, trombocytter
 - eGFR, kreatinin, karbamid
- Endoskopi



Generelt om stabilisering og behandling ved den akutte blødning

ABCDE!

- Ittilskud
- Trendelenborg-leje og væsketerapi (og 4:4:1 blodtransfusion når muligt)
 - BAC-test
- Ring til abdominalkirurg
 - Diagnostik og behandling vha. endoskopi

Take home messages

1

Øvre GI-blødninger er hyppigst og mest alvorlige

2

Blødende ulcus gør ikke ondt

3

Nedre GI-blødninger er typisk selvlimiterende

4

Stabilisér patienten og derefter behandling afhængig af årsag og patientens kliniske tilstand

Tak for i dag

